

2023년도 노인실태조사

오렌지사회정책연구원 · 연구보고서 2024 - 08 · 2024 - 06

조사 설계

본 조사는 오렌지국 「노인복지기본법」 제12조에 근거하여 3년 주기로 실시되는 국가승인통계로, 2023년 조사는 제7차 조사에 해당한다. 오렌지국 복지부가 조사를 주관하고 오렌지사회정책연구원이 조사 설계와 분석을 수행하였다.

조사는 2023년 3월부터 11월까지 전국 65세 이상 노인 10,078명을 대상으로 하였다. 표본은 2022년 인구주택총조사 자료를 표집틀로 하여 17개 광역권과 동부·읍면부를 층화 기준으로 삼은 층화 2단 집락표본설계를 적용하였다.

자료 수집은 사전 교육을 이수한 조사원이 대상자의 거처를 방문하여 태블릿 기반 대인면접조사(TAPI) 방식으로 진행하였다. 최종 응답률은 78.4%였으며, 조사 불능 사유는 부재 41.2%, 거절 35.6%, 건강상 이유 14.8% 순이었다. 응답이 곤란한 중증 인지저하 노인의 경우 주 돌봄자를 통한 대리응답을 허용하였고, 전체 조사표의 4.6%가 대리응답으로 수집되었다. 조사표는 8개 영역 총 312개 문항으로 구성되었다.

가중치는 설계가중치에 무응답 조정과 성·연령·권역별 사후층화를 순차 적용하여 산출하였으며, 본 보고서에 제시된 모든 추정치는 가중치를 적용한 값이다. 비율 추정치의 표준오차는 층화집락 설계를 반영한 테일러 선형화 방법으로 계산하였고, 주요 지표의 상대표준오차는 대체로 5% 미만이었다. 다만 85세 이상 초고령층과 일부 소권역의 세부 추정치는 표본 규모가 작아 해석에 유의할 필요가 있다.

가구 형태와 거주 실태

노인 가구 형태는 부부가구가 가장 큰 비중을 차지하여 전체의 55.1%로 나타났다. 자녀동거가구는 9.4%, 기타 가구는 2.3%였다. 65세 이상 노인 중 독거 노인의 비율은 33.2%였다. 2020년 제6차 조사와 비교하면 부부가구 비중은 1.7%p 증가한 반면 자녀동거가구는 2.9%p 감소하여, 노인 단독 생활 단위의 확대 경향이 지속되고 있는 것으로 확인된다.

거주 주택 유형은 아파트가 48.6%, 단독주택이 39.2%, 연립·다세대주택이 10.5%였다. 점유 형태는 자가가 76.4%로 다수를 차지하였으나, 읍면부 노인의 자가 비율 83.9%와 동부 노인의 자가 비율 72.1% 사이에 뚜렷한 차이가 관찰되었다. 현재 주택에서 10년 이상 거주한 노인은 61.7%였으며, 향후에도 현재 살고 있는 집에서 계속 거주하기를 희망한다고 응답한 비율은 87.2%에 달하였다.

주거 내 안전 설비 보유 수준은 전반적으로 낮았다. 욕실 손잡이를 갖춘 가구는 22.8%, 문턱 제거 등 단차 개선이 이루어진 가구는 17.4%에 그쳤다.

지난 1년간 집 안에서 낙상을 경험한 노인은 6.9%였고, 이 중 39.5%가 화장실과 욕실에서 사고를 겪은 것으로 나타났다. 이는 재가 노인을 대상으로 한 주거 환경 개선 지원의 대상과 범위를 확대할 필요성을 시사한다.

소득과 경제활동

노인의 연간 평균 개인소득은 1,558만원이었으며, 이 가운데 근로소득이 24.1%를 차지하였다. 나머지 소득원의 구성은 공적이전소득 38.6%, 사업소

득 14.8%, 사적이전소득 12.7%, 재산소득 9.8%였다. 소득 5분위 비율은 8.2배로 2020년 조사의 8.7배보다 소폭 축소되었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

경제활동 참여율은 38.4%로 제6차 조사 대비 2.6%p 상승하였다. 종사 직종은 단순노무직이 42.3%로 가장 많았고, 농림어업이 21.9%, 서비스·판매직이 17.6%로 뒤를 이었다. 경제활동을 지속하는 이유로는 생계비 마련이 68.8%로 압도적이었으며, 건강 유지와 사회적 관계 유지를 든 응답은 각각 14.2%와 9.1%였다. 주당 평균 근로시간은 26.4시간으로 조사되었다.

노후 준비 실태를 보면 노후를 준비하고 있거나 준비를 마쳤다고 응답한 비율은 56.3%였다. 주된 준비 수단은 공적연금인 52.4%, 예금·적금이 21.7%였으며, 부동산과 사적연금은 각각 11.9%와 8.3%로 나타났다. 한편 본인의 소득이 생활비를 충당하기에 충분하지 않다고 응답한 비율은 44.9%로, 공적 소득보장제도의 급여 수준 조정과 사각지대 해소가 주요 정책 과제로 확인된다.

건강과 정신건강

주관적 건강상태가 좋다고 평가한 노인은 39.7%, 나쁘다고 평가한 노인은 28.5%였다. 의사로부터 진단받은 만성질환을 3개 이상 보유한 비율은 35.8%였으며, 1인당 평균 만성질환 수는 2.1개였다. 질환별로는 고혈압 58.3%, 당뇨병 25.6%, 관절염 19.4% 순으로 유병률이 높았다. 최근 1개월간 처방약을 복용한 노인은 82.9%로 나타났다.

단축형 노인우울척도(SGDS-K) 기준 우울증상을 보이는 노인의 비율은 11.3%였다. 우울증상 비율은 연령이 높을수록, 그리고 소득 수준이 낮을수록 뚜렷하게 상승하여 85세 이상 집단에서는 18.6%에 이르렀다. 지난 1년간 자살을 생각한 적이 있다고 응답한 비율은 4.2%였으며, 그 이유로는 건강 문제 38.4%와 경제적 어려움 26.1%가 주로 지목되었다.

인지기능 선별검사에서 저하 의심 판정을 받은 비율은 24.7%였으나, 이 중 실제로 의료기관 진료를 받은 경우는 31.2%에 그쳤다. 일상생활수행능력(ADL)에 제한이 있는 노인은 6.4%, 수단적 일상생활수행능력(IADL)에 제한이 있는 노인은 14.1%로 나타났다. 정신건강 서비스 이용 경험률은 3.8%에 불과하여, 예방적 접근과 서비스 접근성 개선이 시급한 것으로 판단된다.